

Tamizaje de ITS y manejo sindrómico

1. Introducción y relevancia clínica

Las **Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)** constituyen una de las principales causas de morbilidad reproductiva, infertilidad y complicaciones obstétricas prevenibles.

A nivel mundial, según la **OMS (2023)**, se registran más de **370 millones de nuevos casos de ITS curables cada año**, siendo las más frecuentes: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Treponema pallidum* (sífilis) y *Trichomonas vaginalis*.

En Chile, el **MINSAL** ha implementado el “**Manejo Sindrómico de las ITS**” como estrategia clave para el diagnóstico y tratamiento oportuno, especialmente en los niveles de atención primaria, donde el acceso a exámenes confirmatorios puede ser limitado.

- En EUNACOM se evalúan con frecuencia los **síndromes de ITS según el protocolo MINSAL**, los **esquemas antibióticos específicos**, y el **tamizaje obligatorio en mujeres embarazadas y jóvenes**.
-

2. Principios del manejo sindrómico

El **manejo sindrómico** consiste en diagnosticar y tratar las ITS **basándose en los signos y síntomas clínicos (síndromes)**, en lugar de esperar confirmación por laboratorio.

Busca **maximizar la cobertura y reducir las complicaciones** derivadas de la demora diagnóstica.

Objetivos:

- Tratar precozmente a la paciente y sus contactos.
- Evitar complicaciones (EIP, infertilidad, transmisión vertical).
- Interrumpir la cadena de transmisión.
- Optimizar el uso racional de antibióticos.
- Unificar la conducta en APS según guías nacionales.

Ventajas:

- Tratamiento inmediato.
- No requiere laboratorio.
- Protocolos simples y estandarizados.

Desventajas:

- Posible sobretratamiento.
- No identifica portadores asintomáticos.
- No diferencia infecciones mixtas sin confirmación.

3. Síndromes principales reconocidos por el MINSAL (2022)

Síndrome	Manifestaciones clínicas principales	Objetivo del manejo
1. Síndrome de flujo vaginal	Flujo anormal, prurito, mal olor, irritación	Tratar causas infecciosas: VB, CVV, TV
2. Síndrome de descarga uretral	Secreción purulenta, disuria en hombres	Tratar gonorrea y clamidia
3. Síndrome de úlcera genital	Lesión ulcerada genital	Tratar sífilis y herpes
4. Síndrome de dolor pélvico bajo	Dolor abdominal bajo, fiebre, dolor cervical	Tratar EIP
5. Síndrome bubónico	Adenopatías inguinales dolorosas	Tratar LGV o chancroide

Cada síndrome tiene un **flujograma diagnóstico-terapéutico** definido por MINSAL, con base en las características clínicas predominantes.

4. Manejo sintromico detallado segun tipo

A.

Síndrome de flujo vaginal

Causas frecuentes

- *Gardnerella vaginalis* → Vaginosis bacteriana.
- *Candida albicans* → Candidiasis vulvovaginal.
- *Trichomonas vaginalis* → Tricomoniasis.

Diagnóstico clínico

- Flujo gris homogéneo con olor → Vaginosis.
- Flujo blanco grumoso y prurito → Candidiasis.
- Flujo verdoso espumoso y prurito → Tricomoniasis.

Tratamiento sintromico

Metronidazol 500 mg VO cada 12 h × 7 días

(+ Clotrimazol vaginal 100 mg × 7 días si prurito intenso).

□ En embarazadas: usar **Metronidazol oral** o **Clotrimazol tópico** (seguros).

Tratamiento de pareja

- Tratar pareja sexual solo si Tricomoniasis.

B.

Síndrome de descarga uretral (hombres)

Causas

- *Neisseria gonorrhoeae* (uretritis gonocócica).
- *Chlamydia trachomatis* (uretritis no gonocócica).

Diagnóstico clínico

- Secreción purulenta uretral, disuria, prurito uretral.

Tratamiento sintomático

- **Ceftriaxona 500 mg IM dosis única**
 - **Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h × 7 días.**

Alternativa: **Azitromicina 1 g VO dosis única.**

Tratamiento de pareja

- Tratar a todas las parejas sexuales de los últimos 60 días.
- Abstinencia sexual hasta completar tratamiento.

C.

Síndrome de úlcera genital

Causas principales

- *Treponema pallidum* → Sífilis (chancro duro).
- *Herpes simple tipo 2* → Herpes genital (úlceras dolorosas).
- *Haemophilus ducreyi* → Chancroide (raro en Chile).

Diagnóstico clínico diferencial

Característica	Sífilis	Herpes	Chancroide
----------------	---------	--------	------------

Dolor	No	Sí	Muy doloroso
-------	----	----	--------------

Número de lesiones	Única	Múltiples	Múltiples
--------------------	-------	-----------	-----------

Base	Limpia	Erosiva	Purulenta
------	--------	---------	-----------

Adenopatía	Indolora	Dolorosa	Supurativa
------------	----------	----------	------------

Tratamiento sintomático

- **Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única**
 - **Aciclovir 400 mg VO cada 8 h × 7 días.**

Si alergia a penicilina: Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h × 14 días (para sífilis).

Tratamiento de pareja

- Tratar pareja sexual en todos los casos.
- Control serológico para sífilis y VIH.

D.

Síndrome de dolor pélvico bajo (EIP)

Diagnóstico clínico

- Dolor pélvico + dolor a la movilización cervical o anexial ± fiebre.
- Excluir embarazo ectópico.

Tratamiento sintomático

- **Ceftriaxona 500 mg IM DU**

- **Doxiciclina 100 mg VO c/12 h × 14 días**
- **Metronidazol 500 mg VO c/12 h × 14 días.**

Hospitalizar si embarazo, absceso, fiebre alta o no mejora en 72 h.

Tratamiento de pareja

- Siempre tratar pareja sexual (gonorrea/clamidia).

E.

Síndrome bubónico (adenitis inguinal dolorosa)

Causas

- Linfogranuloma venéreo (*C. trachomatis* L1–L3).
- Chancroide (*H. ducreyi*).

Tratamiento

- **Doxiciclina 100 mg VO c/12 h × 21 días**
 - Azitromicina 1 g VO semanal × 3 semanas.

5. Tamizaje y diagnóstico en población general (según MINSAL)

Grupo poblacional	Infección a pesquisar	Frecuencia / momento
Mujeres <25 años sexualmente activas	<i>C. trachomatis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>	Anual

Embarazadas	Sífilis, VIH, Hepatitis B, C. <i>trachomatis</i>	1.er control y semana 28
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	VIH, sífilis, gonorrea, clamidia	Anual
Personas con ITS previa	VIH, sífilis, Hepatitis B	En cada episodio
Usuarios de drogas EV	VIH, Hepatitis B y C	En control periódico

Tamizaje VIH y sífilis en embarazo es **obligatorio por ley en Chile**.

6. Seguimiento y control postratamiento

- Reevaluar síntomas a las **72 horas** (EIP, descarga uretral).
- Repetir pruebas serológicas según infección:
 - Sífilis: VDRL a 3, 6 y 12 meses.
 - Gonorrea/clamidia: PCR de control a las 4–6 semanas.
- Educación y consejería: abstinencia sexual hasta curación.
- Promover uso de preservativo y adherencia a tratamiento.

7. Prevención y promoción de la salud sexual

Estrategias MINSAL:

1. Educación sexual integral.
2. Uso correcto y consistente del preservativo.
3. Tamizaje regular y diagnóstico oportuno.

4. **Tratamiento gratuito y confidencial.**
 5. **Vacunación VPH y Hepatitis B.**
 6. **Tratamiento de pareja y contactos.**
 7. **Consejería y no estigmatización.**
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Manejo sindrómico = tratar según cuadro clínico sin esperar exámenes.
2. Síndrome de flujo vaginal → Metronidazol ± Clotrimazol.
3. Síndrome de descarga uretral → Ceftriaxona + Doxiciclina.
4. Úlcera genital → Penicilina benzatina + Aciclovir.
5. Dolor pélvico → Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol.
6. Siempre tratar pareja sexual (excepto VB y CVV).
7. Tamizaje obligatorio de VIH y sífilis en embarazo.



Errores comunes

- Esperar resultados de laboratorio antes de tratar.
- No agregar metronidazol en el esquema de EIP.
- Omitir tratamiento de pareja.
- Usar antibióticos inadecuados (amoxicilina).
- No repetir VDRL postratamiento.

- Confundir úlceras dolorosas (herpes) con chancro sifilítico.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **manejo sintromico** permite tratar ITS basándose en síntomas y signos clínicos.
2. Principales síndromes: **flujo vaginal, descarga uretral, úlcera genital y dolor pélvico**.
3. Esquema más frecuente: **Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol**.
4. **Tratar siempre pareja sexual** y reforzar prevención.
5. Tamizaje universal en **embarazo y mujeres <25 años**.
6. **Penicilina benzatina** sigue siendo el pilar en sífilis.
7. Estrategia clave para **evitar infertilidad, embarazo ectópico y transmisión vertical**.